

CAPÍTULO 2.9

Cardiopatía Coronaria

PERFIL EUNACOM 2.01.09

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Generalidades de la Cardiopatía Coronaria

La cardiopatía coronaria es la **causa más frecuente de Insuficiencia Cardíaca: Generalidades** | **insuficiencia cardíaca** a nivel global. Clínicamente, suele presentarse como una **Insuficiencia Cardíaca: Tratamiento** | **insuficiencia cardíaca** izquierda debido a la afectación estructural primaria del ventrículo izquierdo, aunque existen casos de infarto de ventrículo derecho que pueden dejar como secuela una insuficiencia cardíaca derecha pura.

Diagnóstico

El diagnóstico y la aproximación inicial se basan en la integración clínica y electrocardiográfica:

- **Antecedentes:** Habitualmente el paciente cuenta con el historial de un infarto agudo al miocardio (IAM). Sin embargo, esto no ocurre siempre.
- **ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN**
A veces, existe un infarto que pasa completamente **desapercibido**. En estos casos, el diagnóstico se presume por el antecedente de factores de riesgo cardiovascular importantes en el paciente.

Electrocardiograma (ECG): El hallazgo más característico y de mayor utilidad en pacientes crónicos es la presencia de **ondas Q patológicas** o **complejos QS**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

A diferencia de las alteraciones del segmento ST y modificaciones de la onda T (que suelen normalizarse luego de superar el episodio agudo), las ondas Q **permanecen en el tiempo** marcando la huella del infarto.

Ejemplo EUNACOM: Un paciente con signos de insuficiencia cardíaca que presenta ondas Q en derivaciones inferiores (II, III, aVF) sugiere una secuela anatómica extensa por un infarto inferior antiguo, confirmando la etiología coronaria de su insuficiencia actual.

Ecocardiograma: Herramienta clínica fundamental de segunda línea que permite detectar:

- **Zonas akinéticas:** Áreas que no presentan movimiento, correspondientes a tejido cicatricial inerte.
- **Zonas hipoquinéticas:** Áreas con movimiento disminuido tras una lesión secundaria pos-infarto.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento de la cardiopatía coronaria engloba la terapia clásica de **insuficiencia cardíaca** más la estabilización y profilaxis isquémica:

- **Manejo general de la Insuficiencia Cardíaca:**

- - IECA / ARA-II
- - Beta-bloqueadores
- - Espironolactona
- - **Diuréticos** de asa (según sintomatología congestiva)

- **Manejo preventivo de re-infarto:** El objetivo prioritario es evitar un nuevo evento coronario agudo y manejar agresivamente los factores de riesgo cardiovascular.

EUNACOM CRITERIOS

En este escenario, el fármaco más crucial (incluso por encima del Enalapril) es la **Aspirina (Ácido Acetilsalicílico)**, ya que es la intervención farmacológica que **más aumenta la sobrevida** al prevenir de forma directa que el paciente vuelva a presentar un nuevo infarto agudo en el futuro.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 58 años, fumador de 20 paquetes/año, hipertenso, diabético tipo 2, con colesterol LDL 165 mg/dL, consulta por dolor torácico de esfuerzo. Padre falleció de IAM a los 50 años."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, HTA, DM2, dislipidemia, antecedente familiar de enfermedad coronaria prematura). El riesgo cardiovascular es muy alto. Tratamiento: Estatinas de alta intensidad (Atorvastatina 40-80 mg), meta LDL < 55 mg/dL, cesación tabáquica, control glicémico y de PA.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La cardiopatía coronaria es la principal causa de muerte a nivel mundial
- La placa vulnerable tiene capa fibrosa delgada y gran núcleo lipídico inflamado
- El tabaquismo es el factor de riesgo modificable con mayor impacto al suspenderse
- La meta de LDL en prevención secundaria es menor a 55 mg/dl
- Las estatinas de alta potencia son obligatorias en todo paciente con enfermedad coronaria establecida
- Los scores de riesgo cardiovascular guían la intensidad del tratamiento preventivo
- La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, no solo depósito de lípidos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CARDIOPATÍA CORONARIA)**PREGUNTA 1**

Hombre de 52 años, fumador, hipertenso, con LDL de 160 mg/dl. Sin antecedentes cardiovasculares. Score de riesgo cardiovascular alto. ¿Cuál es la intervención de prevención primaria más importante?

- A)** Iniciar aspirina profiláctica
- B)** Iniciar estatina de alta potencia y suspender tabaco
- C)** Solo cambios de estilo de vida
- D)** Coronariografía diagnóstica
- E)** Solo control de presión arterial

PREGUNTA 2

Paciente post IAM, estabilizado. LDL de 90 mg/dl. ¿Cuál es la meta de LDL en prevención secundaria según guías actuales?

- A)** Menor a 130 mg/dl
- B)** Menor a 100 mg/dl
- C)** Menor a 70 mg/dl
- D)** Menor a 55 mg/dl
- E)** No requiere meta específica, solo usar estatina

PREGUNTA 3

¿Cuál es la característica de la placa aterosclerótica que la hace más propensa a romperse y causar un SCA?

- A)** Capa fibrosa gruesa con calcificación
- B)** Capa fibrosa delgada con gran núcleo lipídico e infiltrado inflamatorio
- C)** Obstrucción mayor al 90% de la luz arterial
- D)** Presencia de trombo organizado
- E)** Calcificación extensa

RESUMEN: CARDIOPATÍA CORONARIA

La cardiopatía coronaria o enfermedad arterial coronaria es la manifestación cardíaca de la aterosclerosis y constituye la principal causa de muerte en el mundo. Se produce por la formación de placas ateroscleróticas en las arterias coronarias que progresivamente reducen el flujo sanguíneo miocárdico. Los factores de riesgo se dividen en modificables (hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, sedentarismo) y no modificables (edad, sexo masculino, antecedentes familiares). La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que comienza con la disfunción endotelial, acumulación de LDL oxidado en la íntima, formación de células espumosas, y progresión a placas fibrosas con núcleo lipídico y capa fibrosa. La placa vulnerable tiene capa fibrosa delgada, gran núcleo lipídico e infiltrado inflamatorio, y es la que se rompe desencadenando el síndrome coronario agudo. Las manifestaciones clínicas abarcan un espectro desde la angina estable crónica hasta el síndrome coronario agudo. La prevención primaria se basa en el control de factores de riesgo con cambios de estilo de vida, estatinas según riesgo cardiovascular global, y manejo de HTA y diabetes. La prevención secundaria en pacientes con enfermedad coronaria establecida incluye aspirina, estatinas de alta potencia, betabloqueadores, IECA y control agresivo de factores de riesgo con metas más estrictas de LDL menor a 55 mg/dl.